

O monotropismo e a sua teia de comorbilidade: ligações diretas e indiretas a condições comportamentais, psiquiátricas e de neurodesenvolvimento

Um brief de investigação citado.

Resumo executivo

O **monotropismo** (Murray, Lawson & Lesser, 2005) é uma teoria da atenção autista que enquadra o autismo como uma diferença na *alocação de recursos*: uma mente monotrópica concentra recursos de processamento num pequeno número de "túneis de atenção" altamente ativados, deixando menos recursos para os canais periféricos. Uma medida de auto-retrato de 2023 — o **Monotropism Questionnaire (MQ)** — fornece a primeira validação empírica, mostrando que pessoas autistas e com TDAH pontuam significativamente mais alto do que controlos não-autistas/não-TDAH [1][2][3]. Um modelo próximo revisto por pares, a conta de **alocação atípica de recursos** de Goldknopf, argumenta que a mesma atenção estreita-intensa pode ligar as características sensoriais, sociais, executivas e motoras do autismo — enquanto avisa que é "mais provavelmente um fator em pessoas autistas com fortes sintomas sensoriais", não a causa única [4].

Porque o monotropismo é uma teoria de *como os recursos são gastos*, plausivelmente repercute-se em muitos domínios. O quadro honesto, no entanto, divide-se em três níveis:

- **Nível 1 — Ligações diretas, empiricamente apoiadas.** A sobreposição autismo-TDAH ("AuDHD") é a mais forte: o MQ mostra

que a atenção monotrópica está elevada em *ambas* as condições, reenquadrando a "cisão monotrópica" (túneis concorrentes ou instáveis) como um fenótipo de atenção real, mensurável [2][3][5]. Sobreposições ao nível do mecanismo — **interoceção** atípica e **disfunção executiva** — são bem evidenciadas e ajudam a explicar problemas a jusante com alimentação, desordem e evitação [6][7][8].

- **Nível 2 — Comorbilidade indireta, de mecanismo partilhado.** O autismo sobrepõe-se notavelmente com a **anorexia/alimentação restritiva** e o **TOC**. Em cada caso a comorbilidade é real e replicada, mas a ponte *melhor evidenciada* é um mecanismo partilhado (interoceção; processamento ego-sintónico vs ego-distónico) em vez do monotropismo especificamente [6][9][10].
- **Nível 3 — Extrapolação plausível ou construtos contestados.** Algumas ligações no enquadramento popular — "montes de perdição" como uma falha de permanência do objeto monotrópica, a agorafobia como um resultado monotrópico primário, a **PDA** como um perfil distinto — assentam em evidência mais fraca ou contestada e devem ser tratadas como hipóteses, não factos estabelecidos [11][12][13].

Ao longo, um tema recorrente: muitos comportamentos que parecem "perturbações" separadas leem-se melhor como **o custo cognitivo de um sistema de atenção estreito em colisão com um mundo polytrópico** — mas apenas algumas dessas leituras foram testadas diretamente.

1. Fundamentos: o que é o monotropismo, e quanto sólido é

O monotropismo propõe que as mentes diferem em como distribuem recursos de atenção. Uma mente **polytrópica** mantém muitos canais de interesse ativos ao mesmo tempo (amplo, rasa, alternância fácil); uma mente **monotrópica** canaliza recursos em poucos "túneis de atenção" intensamente ativados (estreita, profunda, difícil de alternar) [1][3]. Os criadores — Dinah Murray, Wenn Lawson e Mike Lesser — apresentaram primeiro a ideia nas conferências Durham sobre autismo a partir de 1992 e formalizaram-na em 2005, argumentando que explica os traços autistas (interesses especiais, necessidade de mesmice, angústia nas transições, foco no detalhe) melhor do que modelos só-défice [1][14].

O seu estatuto científico mudou nos últimos anos:

- É **empiricamente mensurável**. O MQ (Garau et al., 2023) é um instrumento de auto-relato de 47 itens testado em 1.110 participantes (756 autistas, 354 não-autistas). Participantes autistas e com TDAH pontuaram significativamente mais alto do que controlos [2][3].
- Tem um **primo mecanicista revisto por pares**. O modelo de "alocação atípica de recursos" de Goldknopf (*Frontiers in Integrative Neuroscience*, 2013) operacionaliza a intuição: no autismo, os recursos de atenção são **estreitados** (para menos/menores áreas, modalidades e estádios de processamento, às vezes mais intensamente) e/ou **reduzidos** em capacidade global — um enquadramento que liga explicitamente linguagem, cognição social, atipicalidade sensorial/atencional e diferenças executivas/motoras [4].
- Situa-se **ao lado, não em vez de**, outras teorias cognitivas (Teoria da Mente; coerência central fraca / estilo cognitivo focado no detalhe (Happé & Frith, 2006); disfunção executiva) [4][15].
- Ainda é um **modelo, não um biomarcador**. Goldknopf é explícito que é um fator entre vários, "mais provavelmente" saliente em pessoas autistas com fortes sintomas sensoriais [4]. Murray e colegas enquadram similarmente o monotropismo como uma *lente* unificadora, não uma etiologia completa [1][14].

Implicação para o resto deste brief: o monotropismo é uma ideia organizadora credível, cada vez mais validada, mas o seu *alcance explicativo* em cada comorbilidade tem de ser argumentado caso a caso — não pressuposto.

2. Nível 1 — Ligações diretas: o cluster de neurodesenvolvimento

2.1 AuDHD e a "cisão monotrópica" (*ligação direta mais forte*)

O autismo e o TDAH co-ocorrem muito mais frequentemente do que o acaso prediria: o TDAH está presente em cerca de **30–80%** das pessoas autistas, e o autismo em cerca de **20–50%** daquelas com TDAH [5]; uma meta-análise coloca as taxas de sintomas de TEA em amostras de TDAH em torno de **21%** [16]; um grande estudo Medicaid descobriu que **27%**

dos adultos autistas sem incapacidade intelectual tinham um diagnóstico de TDAH co-ocorrente — cerca de 10× a taxa geral [17]. A sobreposição é substancialmente genética (~50–72%) [18].

O monotropismo ajuda a resolver um velho enigma: se o autismo é "hiperfoco" e o TDAH é "desatenção", porque é que co-ocorrem? O MQ responde empiricamente — **peçoas com TDAH, especialmente AuDHD, são também altamente monotrópicas** [2][3]. O hiperfoco no TDAH (Grotewiel et al., 2022) é conceptualmente quase idêntico ao túnel monotrópico [19]. O enquadramento da "cisão monotrópica" portanto reenquadra AuDHD não como opostos mas como **um sistema instável de túneis de atenção concorrentes ou de alternância rápida**: o cérebro exige foco monotrópico profundo mas não consegue estabilizar o túnel, produzindo a oscilação AuDHD familiar entre envolvimento intenso, burnout rápido e subestimulação crónica [19][20].

Ressalva: o mecanismo dos "múltiplos túneis concorrentes" é *plausível e consistente com os dados do MQ* mas ainda não testado diretamente como dinâmica; deve ser lido como uma hipótese forte.

2.2 Burnout autista e rutura do túnel

O burnout autista — exaustão crónica, perda de competências e tolerância reduzida — está cada vez mais ligado ao custo cumulativo da alternância constante de túnel, camuflagem e exigências que excedem a capacidade, com tempo insuficiente de recuperação/fluxo [20][21]. Esta é uma área onde o monotropismo é heurísticamente poderoso (cada transição forçada é uma rutura de túnel), embora a literatura de burnout em si esteja ainda a amadurecer e o caminho monotropismo→burnout ser em grande parte clínico/em primeira pessoa em vez de experimentalmente estabelecido [20].

2.3 Evitamento de exigências e PDA (*construto contestado*)

Uma exigência — "prepara-te", "preenche este formulário" — pode ser vivenciada como uma intrusão violenta num estado de fluxo. Esta é a conta monotrópica intuitiva do **evitamento de exigências**. O construto mais específico **Pathological Demand Avoidance (PDA)**, cunhado por Elizabeth Newson nos anos 1980 e agora frequentemente reenquadrado

como "Pervasive Drive for Autonomy", descreve uma necessidade de controle e evitamento de exigências ordinárias impulsada pela ansiedade [11][22].

Duas coisas devem ser separadas:

- **O comportamento de evitamento de exigências é real e comum** no autismo, e a conta monotrópica de "rutura do túnel" é uma *história mecanicista* razoável para o pânico e resistência que produz.
- **A PDA como perfil ou subtipo distinto não está estabelecida.** A National Autistic Society do Reino Unido afirma "nenhuma investigação encontrou forte evidência para [a PDA] como um perfil distinto" [11]; o estudo fundacional de Newson foi criticado por **raciocínio circular e sobreinterpretação** (grupos definidos pelos investigadores foram depois "estudados") [12][13]; e revisões notam problemas persistentes com definição, validade do construto e medição [23]. Uma revisão de 2023 é pontualmente intitulada "*Pathological Demand Avoidance: Current State of Research and Critical Discussion*" [13].

Assim, o enquadramento do texto fonte está meio certo: a *experiência* (uma exigência esmaga o túnel) é bem descrita pelo monotropismo; a *entidade de diagnóstico* (PDA) é contestada e não deve ser apresentada como estabelecida.

3. Nível 2 — Comorbilidade indireta, mecanismo partilhado

3.1 Anorexia e alimentação restritiva

A sobreposição autismo–anorexia é robusta e bidirecional: cerca de **20–30%** dos pacientes com perturbações alimentares mostram traços autistas clinicamente significativos, com as taxas mais altas na anorexia nervosa e ARFID [6][24]; inversamente, adultos autistas têm taxas elevadas de perturbações alimentares. Crucialmente, os traços autistas são observados **antes** do início da PA, por isso a sobreposição não é meramente um efeito de inanição [6].

A ponte *mechanicista* melhor evidenciada é a **interocepção** — a percepção dos sinais internos do corpo (batimento cardíaco, saciedade). A interocepção atípica está implicada na etiologia *tanto* do autismo como

das perturbações alimentares e "pode, pelo menos em parte, ser responsável" pela sua comorbilidade [6]. A mesma atipicalidade interoceptiva subjaz à **alexitimia** (dificuldade em identificar/verbalizar emoções), presente em ~50% das pessoas autistas e ela própria ligada à patologia alimentar [7][8].

Onde o monotropismo se encaixa (e não se encaixa): é razoável dizer que uma pessoa monotrópica profundamente num túnel pode *perder* pistas de fome — mas a alegação específica do texto fonte de que "o monotropismo reduz a interoção" sobrestata a cadeia causal. A relação evidenciada é **autismo** → **interoção/alexitimia atípicas** → **vulnerabilidade alimentar**; o monotropismo é uma característica paralela do autismo, não a *causa demonstrada* da diferença interoceptiva [6][7]. A contagem de comida/calorias pode também tornar-se um túnel por direito próprio, mas isto é plausível-mecanismo em vez de testado.

3.2 TOC vs hiperfoco: uma distinção genuína

O autismo e o TOC co-ocorrem substancialmente: ~17% das pessoas autistas cumprem os critérios de TOC, vs ~1–2% na população em geral [9]. Apesar da semelhança superficial (comportamento repetitivo, rigidez), o **motor afetivo difere** e isto está bem estabelecido clinicamente:

- Os interesses e rotinas **autistas** restritos/repetitivos são tipicamente **ego-sintónicos** — agradáveis, autorreguladores, impulsados por interesse, frequentemente reguladores.
- As **compulsões do TOC** são **ego-distónicas** — indesejadas, impulsadas pela ansiedade, executadas para neutralizar os resultados temidos [9][10].

A distinção do texto fonte é portanto correta e apoiada pela evidência, e é confirmada diretamente pelos próprios participantes autistas: num estudo qualitativo relataram que os comportamentos repetitivos são "parte de quem são", enquanto os sintomas de TOC "conflituavam com como se veem a si próprios" [10]. O mesmo estudo enquadrava acertadamente a co-ocorrência como "*Autism is the arena and OCD is the lion*" — os sintomas de TOC podem "sequestrar" os interesses especiais autistas, inflando a sua intensidade e angústia [10]. O monotropismo

adiciona contexto (um túnel pode ser *capturado* por conteúdo de TOC) mas a diferenciação assenta no eixo ego-sintónico/distónico, não no monotropismo per se.

3.3 Ansiedade e perturbações afetivas (o substrato sob a "agorafobia")

A ansiedade está entre as comorbilidades de autismo mais comuns (uma revisão secundária cita ≥ 1 comorbilidade psiquiátrica em ~86% das pessoas autistas) [25]. Dois pontos de mecanismo importam para o cluster comportamental abaixo: (i) a **hiper-responsividade sensorial** e a ansiedade estão ligadas, e através de *condicionamento de contexto* produzem **evitamento comportamental de locais generalizados** (restaurantes, lojas, festas) [26]; (ii) a frequente co-ocorrência de alexitimia/dificuldade interoceptiva significa que os estados emocionais estão muitas vezes mal etiquetados, alimentando ansiedade difusa [7].

4. Nível 3 — Cluster comportamental/funcional: desordem, acumulação, evitamento, retirada social

4.1 Desordem, "montes de perdição", e disfunção executiva

O *fenómeno* é bem apoiado: pessoas autistas e com TDAH mostram taxas elevadas de desorganização e desordem, e a rota melhor evidenciada é a **disfunção executiva** — défices em categorização, tomada de decisão, planeamento e memória de trabalho [8][27]. Sintomas de acumulação estão elevados tanto no TDAH (com uma "ligação especial com desatenção" [8a]) como no autismo [8]; no autismo especificamente, trabalho qualitativo mostra que a dificuldade em descartar está ligada a **afixos de interesse e significado**, não meramente ao valor do objeto [28].

Ressalva sobre o texto fonte: a alegação específica de que a desordem persiste devido a um "**défice de permanência do objeto**" autista ("fora da vista, fora da mente") **não é apoiada por evidência revista por pares** que eu pudesse localizar. A permanência do objeto é tipicamente *intacta ou superior* no autismo; a experiência "fora da vista, fora da mente" lê-se melhor como um efeito de **memória de trabalho/alocação de atenção** (uma mente em túnel não se reorienta para itens armazenados) do que uma falha de permanência do objeto perceptual. O

mecanismo evidenciado para a desordem permanece **disfunção executiva mais afixo de interesse**, que se sobrepõe à população monotrópica/AuDHD mas não é exclusivamente "monotrópica" [4][8][28].

4.2 Comportamento do espectro da acumulação

A perturbação de acumulação afeta ~1,5–6% da população em geral mas está elevada no autismo [29]. Em adultos autistas, a dificuldade tipo acumulação para descartar é frequentemente relatada juntamente com **dificuldades cognitivas (executivas) e fortes afixos de interesse/significado** — os itens são nós numa teia de ideias e utilidade futura, por isso descartar parece perda [28]. Isto é consistente com um *estilo* monotrópico (processamento profundo de objetos) mas, novamente, o motor evidenciado é FE/afixo, partilhado através de condições de neurodesenvolvimento [8].

4.3 Agorafobia e delimitação do "espaço seguro" (*precisa de correção*)

O texto fonte enquadra o confinamento em casa agorafóbico como um resultado monotrópico quase direto. Os dados são mais matizados:

- A agorafobia *está* elevada no autismo — ~**23–25%** dos adultos autistas (sem incapacidade intelectual) vs ~1,3% na população em geral — **mas é menos comum do que a fobia social ou a TAG**, e o efeito concentra-se naqueles sem DI [25].
- O motor melhor evidenciado é a **hiper-responsividade sensorial + ansiedade social**, com evitamento condicionado ao contexto de locais esmagadores — i.e., o comportamento de "espaço seguro" é real mas é **secundário à ansiedade sensorial/social**, não um fenómeno monotrópico primário [25][26].

Assim: o monotropismo ajuda a explicar *porque é que* o mundo exterior se sente disruptivo (imprevisível, polytrópico, esmagador-de-túneis), mas classificar o confinamento resultante como "agorafobia" específica ao monotropismo sobrestata a ligação. É uma evitação impulsionada pela ansiedade sensorial que *se sobrepõe* à experiência monotrópica.

4.4 Retirada social, "info-dumping", e o problema da dupla empatia

A interação social é genuinamente polytrópica — exige o acompanhamento simultâneo de rostos, tom, hierarquia, timing e regras não escritas — por isso é desproporcionalmente dispendiosa para um sistema monotrópico, um ponto consistente com o modelo de recursos de Goldknopf [4]. A intuição do texto fonte é sólida.

Mas o enquadramento mais aguçado, *empiricamente apoiado*, para a rutura comunicacional resultante é o **problema da dupla empatia** (Milton, 2012; 2017): a dificuldade é *bidirecional* e relacional — uma "desjunção na reciprocidade entre dois atores sociais diferentemente dispostos" — não um déficit de empatia unidirecional na pessoa autista [30]. O trabalho empírico mostra agora que observadores não-autistas *tanto detetam como demonstram* o problema da dupla empatia em interações mistas [31]. O "info-dumping" encaixa-se naturalmente: é comunicação que procura profundidade de um sistema monotrópico, que falha quando o parceiro não consegue igualar a profundidade — uma incompatibilidade de estilos de processamento, não uma falta de empatia [30][31].

Lacuna a assinalar: a literatura DEP ainda exclui em grande parte crianças autistas, pessoas não-verbais e pessoas com incapacidade intelectual, por isso a generalização é limitada [32].

5. A fronteira: onde a conta monotrópica chega demasiado longe

Alegação no enquadramento fonte/leigo	Estatuto da evidência	Melhor enquadramento
O monotropismo <i>causa</i> as características do autismo	Parcialmente apoiado (MQ; Goldknopf)	Um fator organizador validado entre vários; mais forte no autismo com sensorial [1][4]
AuDHD = "cisão monotrópica" (túneis concorrentes)	Forte + diretamente mensurável (MQ)	Um fenótipo de atenção real; o mecanismo dinâmico é de nível hipótese [2][3]

Alegação no enquadramento fonte/leigo	Estatuto da evidência	Melhor enquadramento
A PDA é um perfil autista distinto	Contestado	O evitamento de exigências é real; a PDA-como-entidade carece de validade de construto [11][12][13]
O monotropismo <i>reduz a interoção</i> → anorexia	Indireto	A ponte é autismo→interoção/alexitimia→vulnerabilidade alimentar; o monotropismo é paralelo, não a causa mostrada [6][7]
Desordem por um "défice de permanência do objeto"	Não apoiado	Disfunção executiva + afixo de interesse; nenhum déficit perceptual de permanência do objeto evidenciado [4][8][28]
Agorafobia como resultado monotrópico primário	Exagerado	Secundária à hiper-responsividade sensorial + ansiedade social; menos comum do que TAG/fobia social [25][26]
TOC vs "obsessões" monotrópicas diferem no afeto	Bem apoiado	Ego-distónico (TOC) vs ego-sintónico (interesse autista); o TOC pode "sequestrar" túneis [9][10]
O problema da dupla empatia explica a rutura social	Apoiado (mas lacunas)	Incompatibilidade bidirecional; amostras enviesam para adultos verbais sem DI [30][31][32]

6. Questões em aberto

- 1. Teste dinâmico do túnel.** O MQ é uma medida de *traço*. A "cisão monotrópica" (túneis concorrentes/instáveis em AuDHD) é observável em atenção/EEG em tempo real? Largamente não testado.
- 2. Seta causal para a interoção.** Uma distribuição de recursos monotrópicos *produz* atipicalidade interoceptiva, ou partilham uma causa comum a montante? A evidência atual não consegue separar estas [6][7].

3. **Resolução da PDA.** A investigação de evitamento de exigências irá convergir num construto validado, mensurável, ou permanecerá uma categoria leiga/clínica contestada? [11][13]
 4. **Mecanismo da desordem.** A experiência "fora da vista, fora da mente" é um efeito de memória de trabalho/alocação (plausível) ou outra coisa? Nenhum estudo dedicado encontrado.
 5. **Generalizabilidade DEP.** Como opera o problema da dupla empatia para pessoas autistas não-verbais, crianças e pessoas com incapacidade intelectual co-ocorrente? [32]
 6. **Burnout.** Qual é a contribuição específica, testável, da rutura do túnel monotrópico para o burnout autista versus camuflagem, trauma e procura crónica? [20]
-

Fontes

- [1] Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism. *Autism*.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1362361305051398> [2] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A., & Fletcher-Watson, S. (2023). The Monotropism Questionnaire (MQ). Open Science Framework (preprint). Comentário/resumo:
<https://ndconnection.co.uk/blog/monotropism-and-the-monotropism-questionnaire> ; mirror: <https://stimpunks.org/monotropism-questionnaire> [3] Autistic Realms / Neurodiverse Connection (Edgar) — resumo dos achados do MQ (47 itens; N=1.110; autistas + TDAH pontuam significativamente mais alto): <https://autisticrealms.com/monotropism-vs-polytropism-adhd-audhd-autistic-attention> [4] Goldknopf, E. J. (2013). Atypical resource allocation may contribute to many aspects of autism. *Frontiers in Integrative Neuroscience*. PMC3872719.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3872719> [5] Psych Scene Hub — revisão de comorbilidade TDAH e autismo (TDAH em ~30–80% de TEA; TEA em ~20–50% de TDAH; cita Lau-Zhu 2019; Hollingdale 2019):
<https://psychscenehub.com/psychinsights/adhd-and-autism-comorbidity-a-comprehensive-review> [6] Adams, K. L., Murphy, J., Catmur, C., & Bird, G. (2022). The role of interoception in the overlap between eating disorders and autism: methodological considerations. *European Eating Disorders Review*. PMC9543236.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9543236> [7] Klein, M., Witthöft, M., & Jungmann, S. M. (2025). Interoception in individuals with autism spectrum disorder: a systematic literature review and meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry* (10.3389/fpsyt.2025.1573263) — ~50% das pessoas autistas têm alexitimia, mediada por défices interoceptivos.

<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2025.1573263/full> [8] Morein-Zamir, S., Kasese, M., Chamberlain, S. R., & Trachtenberg, M. (2020). Elevated levels of hoarding in ADHD: a special link with inattention. *Journal of Psychiatric Research*. PMC7612156.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7612156> — [8a] a "ligação especial com desatenção" é o próprio subtítulo do artigo. Veja também Drake Institute sobre TDAH/disfunção executiva:

<https://drakeinstitute.com/articles/adhd/adhd-and-executive-dysfunction-connection> [9] Animosanopsychiatry — resumo de revisão sistemática: ~17% das pessoas autistas cumprem os critérios de TOC vs ~1–2% população em geral; distinção ego-sintónico vs ego-distónico:

<https://animosanopsychiatry.com/blog/ocd-vs-autism-similarities-differences-and-overlaps> [10] Long, H., Cooper, K., & Russell, A. (2024). "Autism is the arena and OCD is the lion": autistic adults' experiences of co-occurring OCD and restricted/repetitive behaviours (qualitativo). PMC11497754. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11497754> [11] National Autistic Society — Demand avoidance ("nenhuma investigação encontrou forte evidência para [a PDA] como um perfil distinto"):

<https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/behaviour/demand-avoidance> [12] *Frontiers in Education* (2024). Methods of studying PDA — crítica do raciocínio circular de Newson (Green et al. 2018; O'Nions & Eaton 2020):

<https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2024.1230011/full> [13] Kildahl, A., et al. (2023). Pathological Demand Avoidance: Current State of Research and Critical Discussion. PubMed 36892327. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36892327> [14] Murray, F. (Lawson) (2018). Me and Monotropism: a unified theory of autism. *The Psychologist* (BPS). <https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism> [15] Happé, F., & Frith, U. (2006). The weak coherence account: detail-focused cognitive style in ASD. *J Autism Dev Disord* 36:5–25 (citado via estudo comparativo *Frontiers* 2024):

<https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2024.1348074/full> [16] Hollingdale, J., et al. (2019). Meta-analytic review of

ASD symptoms in ADHD (citado via Psych Scene Hub e Autistica):
<https://www.autistica.org.uk/what-is-autism/adhd-and-autism> [17]
 Children's Hospital of Philadelphia — 27% dos adultos autistas sem DI tinham TDAH co-ocorrente (~10× geral):
<https://www.chop.edu/news/rates-adhd-remain-high-adulthood-among-patients-autism> [18] Behavioral Innovations — resumo da sobreposição genética (~50–72%): <https://behavioral-innovations.com/blog/the-sudden-rise-of-adhd> [19] Autistic Scholar — "Revisiting monotropism" (AuDHD como túneis concorrentes; referências Grotewiel et al. 2022 sobre hiperfoco do TDAH): <https://www.autisticscholar.com/monotropism> [20] Neurodiverse Connection (Edgar) — Monotropism, young people and autistic burnout: <https://ndconnection.co.uk/blog/monotropism-young-people> ; Autistic Realms — Reclaiming rest: <https://autisticrealms.com/reclaiming-rest-autistic-burnout-monotropism-and-resistance> [21] National Autistic Society — What is monotropism? (estados de fluxo; referências Heasman et al. 2024 "autistic flow theory"): <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism> [22] PDA North America — What is PDA? (Newson, anos 1980; reenquadramento "Pervasive Drive for Autonomy"): <https://pdanorthamerica.org/what-is-pda> [23] O'Nions, V., et al. (2016). Identifying features of PDA using the DISCO. PMC4820467. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4820467> [24] Nickel, K., Maier, S., Endres, D., & Joos, A. (2019). Systematic Review: Overlap Between Eating, Autism Spectrum, and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. *Frontiers in Psychiatry*. PMC6796791 (cita também Westwood, Mandy & Tchanturia 2017; Huke et al. 2013). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6796791> [25] Discussing Psychology (Loker) — agorafobia no autismo ~23–25% (sem DI) vs ~1,3% geral; menos comum do que fobia social/TAG (fonte secundária, baseada em Helles et al. 2020 e Lugnegård et al. 2012): <https://www.discussingpsychology.com/agoraphobia-and-autism-are-they-intrinsically-linked> [26] Green, S. A., & Ben-Sasson, A. (2010). Anxiety disorders and sensory over-responsivity in children with ASD: is there a causal relationship? *Journal of Autism and Developmental Disorders* — condicionamento de contexto e evitamento. PMC2980623. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2980623> [27] Embrace Autism — Autism and hoarding (função executiva, tomada de decisão): <https://embrace-autism.com/autism-and-hoarding> [28] Goldfarb, Y.,

Zafrani, O., Hedley, D., & Yaari, M. (2021). Autistic adults' subjective experiences of hoarding and self-injurious behaviors (qualitativo). *Autism*. PMC8264636. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8264636>

[29] Abouzed, M., Gabr, A., Elag, K. A., Soliman, M., Elsaadouni, N., Elzahab, N. A., & Barakat, M. (2024). The prevalence, correlates, and clinical implications of hoarding behaviors in high-functioning autism. *Scientific Reports* (s41598-024-75371-8). <https://www.nature.com/articles/s41598-024-75371-8>

[30] Milton, D. (2012). On the ontological status of autism: the 'double empathy problem'. *Disability & Society* 27(6):883–887 ; Milton (2017) extensão. Resumo: <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/double-empathy>

[31] Jones, D. R., Botha, M., Ackerman, R. A., & King, K. (2024). Non-autistic observers both detect and demonstrate the double empathy problem when evaluating interactions between autistic and non-autistic adults. *Autism*. PMC11308351. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11308351>

[32] Wikipedia — Double empathy problem (lacunas de investigação reconhecidas: crianças, não-verbais, incapacidade intelectual): https://en.wikipedia.org/wiki/Double_empathy_problem

Nota sobre os níveis de evidência: Nível 1 = medição direta, replicada (MQ; taxas AuDHD); Nível 2 = comorbilidade replicada com um mecanismo partilhado evidenciado; Nível 3 = extrapolação plausível, fonte única ou construto contestado. Veja §5.